

33 - 01-Révision Sémiologie ophtalmologique (Teams) - Pr.Hajji

(0:01 - 0:17)

S'il vous plaît, il y a un fond de bruit, désactivez vos micros. C'est bon. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez des explications à demander ou quelque chose que vous n'avez pas bien saisi? Ou je démarre la séance de révision.

(0:23 - 0:47)

Donc, je crois que je vais démarrer et la séance va être interactive. À chaque diapositive, vous pouvez m'interrompre pour me demander des explications. Donc, une petite révision générale du cours.

(0:47 - 1:13)

Et à la fin, on aura une session de questions des cas cliniques ou des QCM. En fait, une petite révision du cours. Alors, chaque patient qui vient en ophtalmologie pour une urgence ou une consultation normale, on commence par l'interrogatoire pour tout examen en médecine générale.

(1:13 - 1:24)

Donc, ça, c'est la base de la sémiologie générale et je ne cesse de le répéter. Donc, il faut identifier le patient, s'assurer de son identité. L'âge, c'est très important pour nous, c'est très, très important.

(1:24 - 1:40)

Je le répète à chaque fois, c'est le risque de l'amblyopie pour certaines pathologies chez l'enfant. En plus, il y a des pathologies spécifiques de l'enfant, d'autres spécifiques pour le sujet plus âgé. Les antécédents, bien sûr, personnels médicaux et chirurgicaux et surtout les antécédents ophtalmologiques.

(1:40 - 2:00)

Alors, le motif de consultation, l'ancienneté, le mode évolutif, aigu ou chronique ou parfois, s'il est variable. Alors, les principaux signes d'appel en ophtalmologie, c'est la baisse de vue. Généralement, c'est des patients qui viennent pour une baisse de l'acuité visuelle, soit de loin.

(2:00 - 2:09)

Généralement, c'est ça, surtout pour les myopes. Il faut dire que l'amyopie, c'est une pandémie. On voit de plus en plus de myopes à travers le monde.

(2:10 - 2:31)

Et à partir de la quarantaine, c'est des patients qui vont consulter pour la vision de près, soit pour la difficulté de lire ou l'exercice d'activité en vision de près, ou parfois les deux. La douleur qui peut être superficielle, profonde, une irritation ou autre. Alors, parfois, c'est des patients qui consultent pour un œil rouge.

(2:31 - 2:53)

Il faut savoir que les trois signes cliniques, les principaux trois signes cliniques en ophtalmologie, c'est l'œil rouge, douloureux, avec ou sans baisse de l'acuité visuelle. Alors, la composition des trois signes cliniques va avoir plusieurs tableaux ou plusieurs étiologies. D'autres, la fatigue visuelle, par exemple, en période des examens, la myodésopsie ou mouche volante.

(2:53 - 3:06)

C'est un signe indirect d'un décollement postérieur du vitre. Pas le décollement de rétine, mais le décollement postérieur du vitre. Donc, il faut savoir examiner la rétine, un strabisme ou une hémianopsie.

(3:07 - 3:24)

Alors, j'en passe. Alors, ici, c'est un test spécifique, spécifique surtout pour la pathologie particulière du sujet âgé qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est un signe de vieillissement rétinien.

(3:24 - 3:33)

Donc, c'est des sujets d'un certain âge. Parfois, ils sont intellectuels. Généralement, il est détecté chez des sujets intellectuels parce que c'est des gens qui lisent beaucoup.

(3:34 - 3:48)

Et ils commencent à voir des lignes qui sautent ou des lignes qui sont déformées. Alors, on demande à la personne de fermer œil par œil et de fixer le point rouge central. Et il va voir une petite tâche sombre centrale, ce qu'on appelle un scotum.

(3:49 - 4:03)

Donc, tout ce qui est sombre, il est très mal vu. Et la déformation ou l'ondulation des lignes, ce qu'on appelle les métamorphopsies. Alors, la diplopie, je répète, c'est une vision double d'un objet qui est simple.

(4:03 - 4:17)

Alors, si l'objet est double, ce n'est pas une diplopie. Il peut être unilatéral en fonction de la direction du retard. L'exophtalmie, c'est la protrusion de l'œil en dehors de son cadre orbitaire

à l'opposé de l'énophthalmie.

(4:17 - 4:27)

Ça veut dire que c'est le globe oculaire qui est enfoncé. Alors, tout ça, c'est des signes sémiologiques. Bien sûr, il faut bien apprendre, bien saisir les différentes définitions des différents termes.

(4:28 - 4:43)

Alors, exemple, l'exemple le plus courant, c'est l'exophtalmie basse de Vienne. C'est un patient qui consulte, qui est suivi pour la maladie de base 2 et qui présente stable clinique. Ça saute aux yeux, même s'il n'a pas un bilan thyroïdien ou n'est pas connu pour une dysthyroïdie.

(4:44 - 4:58)

Premier bilan à faire, c'est le dosage des hormones thyroïdiennes. Alors, la mesure d'acuité visuelle, c'est toujours œil par œil, avec ou sans correction, et de loin et de près. Et ici, je vous expose les échelles pour la vision de loin et la vision de près.

(4:59 - 5:12)

L'examen des annexes qui va identifier le ptosis. Alors, c'est quoi le ptosis? C'est une chute de la paupière supérieure ou une rétraction à l'opposé. Exemple, l'orbitopathie dysthyroïdienne, une rougeur.

(5:12 - 5:18)

Alors, les caractéristiques de cette rougeur. Une tumeur d'infection. Il peut être tumorale, cancéreuse ou autre.

(5:18 - 5:27)

Une tumeur bénigne, inflammatoire ou autre. Alors, l'exophtalmie. La sémiologie de l'exophtalmie, c'est est-ce qu'elle est unilatérale ou bilatérale.

(5:27 - 5:43)

Alors, une exophtalmie unilatérale sur un garçon, un petit garçon, c'est une étiologie cancéreuse. C'est un cancer musculaire, ce qu'on appelle un rhabdomyo-sarcome orbitaire. Ça, c'est un signe clinique qui ne rate pas.

(5:43 - 5:54)

Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Une exophtalmie chez un petit garçon, unilatérale, inflammatoire, non-axiale, c'est un cancer chez ce petit garçon. Donc, l'exophtalmie unie ou bilatérale.

(5:55 - 6:07)

Bilatérale, c'est classiquement la dysthyroïdie basse de Vient. Axile ou pas, ça veut dire axile, c'est dans le même axe de l'œil. Ou pas, ça veut dire que l'œil est dévié en haut, à droite, à gauche ou en bas.

(6:08 - 6:21)

Réductible, ça veut dire qu'on tente de réduire l'exophtalmie. Est-ce qu'il est possible ou pas ? Ici, c'est des photos qui témoignent d'un ptosis. Chez l'adulte, il n'y a pas d'urgence.

(6:21 - 6:42)

Mais je répète, chez l'enfant, toujours, toujours l'urgence. C'est le risque d'ombliopie. Comment on va savoir si l'axe visuel est caché par ce ptosis ou par l'obstacle, quel que soit ? Comment on va savoir si l'axe visuel est caché ou pas ? On projette une source lumineuse droit devant.

(6:43 - 6:52)

Sur l'œil qui n'a pas de ptosis, on voit l'axe visuel. C'est la petite projection de lumière sur la cornée. De l'autre côté, il n'y a pas.

(6:53 - 7:01)

Le ptosis cache l'axe visuel. C'est une urgence à le prendre en charge. Ici, c'est un signe qui est très courant, très fréquent.

(7:01 - 7:14)

Vous allez le voir au cours de votre exercice. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour identifier un chalazion qui est un granulome inflammatoire. Quelle est la cause ? C'est une rétention de produits de sécrétion des glandes meibomius.

(7:15 - 7:30)

C'est quoi les glandes meibomius ? Ce sont des glandes spécifiques de la sécrétion lipidique des larmes. Donc le canal excréteur est obstrué pour n'importe quelle raison, pas obligatoirement pathologique. Et l'accumulation, d'abord une accumulation purement physique.

(7:30 - 7:38)

Mais par la suite, on aura une inflammation et peut-être une supérotation. C'est un signe qui est très courant. Le chalazion est très fréquent.

(7:39 - 7:48)

Et le traitement, au début, rien de plus simple que physique. Puisque c'est des sécrétions

lipidiques, c'est comme du beurre. C'est appliquer une compresse qui est chaude, ici.

(7:48 - 7:56)

C'est réchauffer tout ce qui est lipidique à l'intérieur. Et faire un massage. Essayer de vaincre l'obstacle au niveau du canal excréteur.

(7:56 - 8:04)

Et vider la collection. Et le traitement est terminé. Alors, je répète, c'est une exophtalmie, ici.

(8:05 - 8:14)

Inflammatoire, non-axile. Vous voyez qu'elle est déviée vers le bas. Bien sûr, ici, elle est inflammatoire.

(8:15 - 9:00)

Ici, c'est un rhabdomyosarcome orbitaire chez ce petit garçon. Le rhabdomyosarcome, c'est un cancer décédé. ... à partir de ... Je vois, entre temps, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Comme ça, les phosphènes ... Alors, les phosphènes peuvent être une atteinte de quelle partie de l'œil? Alors, c'est quoi les phosphènes? Quand on a les rapports anatomiques du vitré, on a dit, dans les cours d'anatomie, de sémiologie, que le vitré est la plus ... avec la rétine.

(9:01 - 9:10)

Et certains rapports, ils sont très solides. Surtout au niveau de la papille, au niveau de la macula, les parois vasculaires, tout ça, c'est des rappels pour vous. Et la périphérie rétinienne.

(9:11 - 9:26)

À un moment naturel des choses de l'âge, on aura un décollement postérieur du vitré. Tout le monde va passer par cette étape. Alors, au cours de ce décollement postérieur du vitré, on aura ce détachement entre le vitré et la rétine.

(9:26 - 9:48)

Et le résultat, création d'un signal électrique, parce que les cellules sont très attachées à ce niveau. Alors, ce détachement, on espère qu'il se passera sans dégâts. Sinon, autrement, ce détachement peut créer un arrachement d'une partie de la rétine.

(9:49 - 10:10)

Et dans ce cas, c'est une déchirure rétinienne. Donc, c'est quoi ? Pour le phosphène, quand on a des phosphènes, et mieux des options autres, il faut examiner la rétine à la recherche de déchirure. Et surtout, c'est des signes qui sont vitréens, et c'est des signes d'un décollement

postérieur du vitré.

(10:12 - 10:23)

Alors, pour l'orabdomysarcom, c'est beaucoup plus chez l'enfant. Alors, l'orabdomysarcom orbitaire, je parle ici de l'orbitaire. Alors, l'orabdomysarcom, à l'absolu, c'est une tumeur de muscles striés.

(10:24 - 10:41)

Tous les organes possèdent des muscles striés. Mais quand je parle de l'orabdomysarcom orbitaire, oui, c'est un cancer de jeunes garçons, aux alentours d'entre 7 et 10 ans. Alors, la palpation de cadran.

(11:01 - 11:20)

Une paralysie oculomotrice, soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Alors, quel est notre instrument magique, notre ophtalmologie qui permet l'examen? C'est la lampe à fente. L'ample à fente, c'est l'équivalent d'un stéthoscope.

(11:21 - 11:26)

Il permet plusieurs grossissements. Il permet une vision qui est binoculaire. Il a plusieurs éclairages.

(11:26 - 11:43)

Et il a une fente qui permet une vision en trois dimensions des différents segments, de l'antérieur et du postérieur. Alors, ici, une vision du segment antérieur. Alors, vous voyez une fente au niveau de la cornée, une deuxième fente au niveau du plan irido-crystallinien.

(11:43 - 11:54)

Et entre les deux, c'est la chambre antérieure. Et ici, une image du plan postérieur. Alors, examen à l'intérieur de l'œil.

(11:55 - 12:17)

Alors, l'examen, on a dit que la rougeur, c'est parmi les signes principaux. La rougeur, est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'elle est vive? Est-ce qu'elle est diffuse? Alors, elle peut avoir maintes étiologies. Alors, ici, par exemple, c'est une hémorragie sous-conjonctivale qui peut être spontanée, au réveil, ou elle peut être d'origine traumatique.

(12:17 - 12:28)

Ici, c'est une rougeur qui est diffuse. Et la cause principale, soit une kératite, soit une infectieuse. Par exemple, une conjonctivite bactérienne.

(12:29 - 12:45)

Alors, ne pas oublier, déverser la paupière et rechercher un corps étranger de l'autre côté. Alors, pour les conjonctivites, devant une sécrétion toujours, c'est une conjonctivite qui est bactérienne ou virale surinfectée, par exemple. Les papilles, c'est un signe de conjonctivite allergique.

(12:45 - 13:02)

Et les follicules, devant des follicules, il faut examiner les adénopathies pré-thragiennes et c'est une conjonctivite virale. Généralement, c'est un contexte qui est épidémique. On trouve que dans les mêmes familles, il y a plusieurs personnes qui sont touchées.

(13:03 - 13:19)

Un des virus les plus connus, c'est l'adénovirus qu'on appelle en arabe « souhai ». Alors, examiner une adénopathie pré-thragienne, pas obligatoirement, mais c'est un signe en faveur d'un adénovirus. Adéno, ça veut dire présence d'adénopathie. Alors, des images.

(13:19 - 13:25)

Ici, sécrétions très périllantes. Et ici, quelques papilles. C'est une conjonctivite.

(13:26 - 13:38)

Quand on regarde les pays ensoleillés, c'est un ptéridion. C'est l'envahissement de la cornée par la conjonctive. Ça n'a rien de grave avec un truc qui est malin, non? C'est un envahissement.

(13:38 - 13:48)

C'est très bénin. Sauf que s'il est très envahissant, il peut arriver même jusqu'à l'axe visuel et le cacher. Et parfois, il peut entraîner des astigmatismes.

(13:51 - 14:05)

Alors, l'examen, bien sûr, de bord libre, la recherche de cils trichiasiques, l'anthropion, l'extropion, les points malins, l'acrymo, tout ça, j'en passe. Vous l'avez déjà dans le cours. Alors, j'essaie d'être plus rapide.

(14:05 - 14:22)

Alors, les mesures de tonus oculaire. Alors, le palpé, l'examen peut être palpé bidi, avec deux doigts. Mais c'est un examen qui est très, très approximatif, surtout en situation d'urgence, c'est des patients qui sont non coopérants et permet de dépister des grandes hypertonies.

(14:22 - 14:38)

Exemple, dans le cadre d'un glaucome, par la fermeture de l'angle. L'examen de dépistage, ça veut dire dépistage de masse. Quand on a une consultation bien pleine, on ne peut pas stériliser entre deux malades à chaque fois.

(14:38 - 14:47)

Donc, on peut faire un dépistage de masse. C'est le tonomètre à air pulsé. Mais par contre, l'examen le plus précis, c'est le tonomètre à aplanation.

(14:48 - 15:04)

C'est l'application d'un cône à aplanation sur la corne après une goutte d'anesthésique. Et une hypertonie, classiquement, c'est à partir de 22, sachant que ce n'est pas une valeur qui est absolue. Il faut la référer à l'épaisseur de la cornée.

(15:06 - 15:23)

Alors, le réflexe photomoteur, il peut être utile chez nous en ophtalmologie. Il peut être utile en neuro-ophtalmologie. Dans le cadre, par exemple, d'un traumatisme crânien, plein de pathologies neurologiques, et également les neuropathies optiques.

(15:24 - 15:38)

Alors, le direct, c'est quand on projette directement sur l'œil. Et le consensuel, c'est voir la réactivité de la pupille quand on projette au niveau de l'œil contralatéral. Alors, l'examen de la cornée.

(15:39 - 15:44)

Alors, ici, quelques images. Ça ne doit pas rater. On instille une goutte de la fluoresceïne.

(15:45 - 15:50)

Cette arborisation, elle est caractéristique. Elle ne doit pas rater. C'est un herpès.

(15:50 - 16:01)

Ici, quelques pointillés, mais qui sont à la face postérieure de la cornée. C'est des précipités rétrodesmétiques qui sont caractéristiques des uveïdes. Alors, une autre image caractéristique.

(16:01 - 16:15)

Ça ne doit pas rater. Alors, quelle est la spécificité? C'est une infection qui répond très, très bien aux antiviraux. D'ailleurs, c'est le seul virus pour lequel on a un traitement antiviral qui est efficace, primo.

(16:15 - 16:25)

Et secondo, c'est une contre-indication absolue, absolue au corticoïde. Absolue. Alors, le premier réflexe chez les patients qui ont des yeux rouges très douloureux, ils partent chez le pharmacien.

(16:26 - 16:59)

Alors, yeux rouges douloureux, ils donnent un antibiotique ou une association antibio-corticoïde. Alors, quel est le résultat? Le virus est hyper content d'avoir une immunodéficience et toute la cornée devient ulcéreuse et même l'ulcère va creuser jusqu'à fente de la cornée, une perforation de la cornée et une perte définitive de l'oeil. Donc, on parle d'une keratite herpétique banale qui est traitée facilement en quelques jours à une perte définitive de l'oeil.

(17:00 - 17:09)

C'est ça le résultat d'une application de corticoïde. Alors, c'est un patient qui a appliqué deux gouttes de corticoïde et voilà le résultat. Pratiquement toute la cornée est envahie par l'ulcère.

(17:11 - 17:29)

Alors, une autre cause d'un nez rouge douloureux, tout ça c'est de l'asthmiologie, c'est le cercle périkeratique. C'est une rougeur qui est vraiment localisée au porteur de la cornée, donc au niveau du lymph. Alors, au-delà, vous voyez que c'est blanc, mais aux alentours du lymph, c'est vraiment rouge.

(17:31 - 17:48)

Plusieurs étiologies, mais j'insiste sur la GFA, c'est le crise de glaucombe par fermeture de l'ongle, la keratite, quelle que soit la cause de la keratite. La keratite, c'est une inflammation de la cornée, y compris par exemple un abcès de cornée. L'abcès, c'est une keratite bactérienne, et l'uveïte antérieure.

(17:48 - 17:58)

Donc ça, c'est une question hyper sortable pour l'examen. Ici, c'est quoi le diagnostic ? C'est une keratite bactérienne. Alors, vous voyez un ulcère.

(17:59 - 18:14)

Alors, dans le cours d'anatomie, on avait vu que la couche la plus antérieure, c'est l'épithélium. Il faut savoir que l'épithélium, il protège d'une façon très importante la cornée. Donc, tant qu'on a un épithélium, il n'y a jamais l'invasion de la cornée par un agent pathogène.

(18:15 - 18:30)

Mais une fois qu'on a un ulcère, on a la porte pour la pénétration de germes pathologiques. Donc, on a un ulcère, et tout ce qui est blanc, ici, c'est un abcès. Ici, c'est un abcès qui est grave,

parce qu'il est grand, parce qu'il est central.

(18:31 - 18:40)

Sur un ulcère, donc, c'est un abcès. C'est une keratite bactérienne de l'œil. Donc, si vous permettez, je vais jeter un coup d'œil encore une fois.

(18:46 - 19:13)

Alors, le keratocone, c'est quoi le traitement d'un keratocone ? Alors, si je finis la partie de la cornée, je parle du keratocone, d'accord. Ici, alors, l'œdème de cornée, par exemple, dans le cadre traumatique ou crise de glaucome à angle fermé de l'angle, ici, c'est quoi le diagnostic ? C'est un hématoconus. C'est un envahissement de la cornée par des globules rouges.

(19:13 - 19:24)

Alors, vous voyez le teint qui est un petit peu brunâtre, c'est quoi ? C'est le teint du fer, de l'hémoglobine. Donc, à ce stade, on n'a pas de traitement. Le seul traitement, c'est une greffe de cornée.

(19:24 - 19:38)

Remplacez cette cornée qui est opaque par une cornée qui est transparente. Autre signe clinique pour la cornée, c'est la mégaloconus. Alors, vous voyez ici, si vous devinez que c'est un bébé de quelques semaines.

(19:39 - 19:53)

Alors, elle a une cornée, généralement, le diamètre horizontal de la cornée, c'est 11,5 millimètres chez l'adulte. Alors, pour ce bébé, elle est de 13 millimètres. Donc, vous voyez que c'est une mégaloconus.

(19:54 - 20:03)

Donc, c'est une augmentation de diamètre de cornée. Ça ne doit pas rater. Alors, pourquoi à chaque fois je projette ces diapos ? Parce qu'on n'a pas besoin d'un examen paraclinique.

(20:04 - 20:13)

Quelqu'un dans votre entourage, vous connaissez, elle a un bébé qui a ce tableau clinique. Un seul diagnostic, c'est un glaucome congénital. C'est une urgence diagnostique thérapeutique.

(20:14 - 21:17)

Alors, une mégaloconus, ça veut dire une cornée qui est grande et qui est opaque, il n'y a pas d'autre diagnostic. On a deux éléments cliniques et c'est un glaucome congénital de pronostic très méchant si on laisse sans traitement, c'est une cécité garantie. Alors, la cornée, ce n'est pas

ici, c'est jusqu'ici.

Alors, ce microscope, c'est un bébé qui a des cornées de 13 millimètres. Alors, avant de passer à la chambre intérieure, c'est quoi le keratocone? Alors, pour vous rapprocher un petit peu du keratocone, généralement, on dit que, ou là, pour simplifier, je dis que pour la cornée, elle a la forme d'un ballon de foot et parfois, dans des cas pathologiques, on appelle le keratocone, c'est une déformation conique. Il va se transformer en si je veux dire, un ballon de rugby.

Ça veut dire qu'elle devient conique. Alors, c'est quoi le traitement? En fait, c'est quoi l'objectif du traitement d'abord? C'est des personnes qui voient très mal, qui ont un astigmatisme très, très, très important. Donc, au début, l'objectif, ce n'est pas de traiter le keratocone.

(21:17 - 21:26)

L'objectif, c'est d'améliorer la vision des patients keratoconiques. Donc, au début, ils voient bien avec leurs lunettes, donc tant mieux, on est bien. Les malades, ils sont contents.

(21:26 - 21:44)

Mais à un certain stade, ils ne sont plus contents et les lunettes ne servent à rien. À ce stade, il faut passer à autre chose et sans des lentilles de contact spécial, une lentille spéciale keratocone. C'est vraiment des lentilles surmesures parce qu'un keratocone ne ressemble pas à un autre.

(21:45 - 22:00)

Donc, c'est des surmesures. Pour améliorer la vision, ce sera des lentilles rigides spéciales keratocones. Également, c'est une pathologie du sujet jeune.

Donc, c'est une cornée. Généralement, on dit qu'elle est un petit peu molle. Il faut la rigidifier.

(22:00 - 22:25)

C'est un traitement qui est spécial. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous parce que c'est très spécifique. À un stade très évolué de la maladie, la cornée peut devenir opaque.

Peu. Le risque est minime, mais peu. À ce stade, on peut avoir recours à la greffe de cornée.

J'espère que j'étais un petit peu claire dans ce sujet. C'est un sujet qui est très pointu. Un cours qui est particulier.

(22:26 - 22:42)

Je passe pour l'examen du chambre antérieur. Bien sûr, la profondeur. On a dit tout à l'heure pour le glauque en parfermeture de langue.

Un premier signe, c'est l'œdème de cornée. On a dit un tonus qui est très élevé. J'ai déjà cité

deux signes.

(22:42 - 23:21)

Ça peut être une question d'examen. Une hypertonie aiguë. On a dit qu'un palpébis digital peut suffire.

Alors, si on arrive à mesurer, parce que ce sont des patients qui sont très peu coopérants, si on arrive à mesurer, c'est des tonus dans les quarantaines, parfois dans les cinquantes. Automatiquement, au palpébis digital, c'est des glauques très, très dures. Deuxième signe, c'est un œdème très important.

Troisième signe, c'est une profondeur très, très étroite, pratiquement une A-talamie. A-talamie. A, elle est privative.

Il n'y a pas de quelque chose. A, elle est privative. Talamie, c'est la chambre antérieure.

(23:22 - 23:36)

Un autre signe spécifique pour le glauque en gueule fermée, c'est des gens qui peuvent venir pour des signes digestifs. Tellement la douleur est importante, il peut s'agir de vomissements ou quelque chose d'autre. A tort, ils peuvent venir pour des signes digestifs.

(23:37 - 23:49)

Mais bon, il faut éliminer autre chose. Dans la chambre antérieure, on peut avoir un phénomène de tantal, c'est-à-dire des cils inflammatoires ou un hypopion carrément du pus. L'hypéma, c'est la présence de sang.

(23:50 - 24:03)

Ici, c'est du sang qui stagne. Ici, encore une fois, on a un abcès de couronnée grave, centrale et une grande quantité de pus dans la chambre antérieure. Alors, l'examen de l'iris avec les nodules.

(24:04 - 24:10)

Ici, les signes de chirurgie stalinienne. Ici, c'est un gamin qui est né sans iris. A, toujours privatif.

(24:10 - 24:25)

A n'iridie, c'est un enfant qui n'a pas d'iris. Alors, les différents stades. Ici, je passe un chapitre aussi intéressant qui est la cataracte.

(24:25 - 24:35)

La cataracte, c'est la première cause de cécité à travers le monde mais c'est une cécité qui est

réversible. Donc, il ne faut pas laisser les gens entraîner jusqu'à ce stade. Déjà, c'est une cataracte totale.

(24:35 - 24:53)

Si une personne d'un certain âge est au stade de perception lumineuse positive, à peine elle arrive à percevoir est-ce que la lumière est allumée ou pas. Donc, c'est la première cause de cécité à travers le monde mais c'est une cécité qui est réversible. Alors, ici, c'est une cataracte unilatérale chez un enfant.

(24:54 - 25:02)

Alors, la cataracte sénile, on peut dire que ce n'est pas une pathologie. C'est un phénomène physiologique de vieillissement. Mais la cataracte chez un enfant, elle n'est jamais normale.

(25:02 - 25:41)

Elle est toujours maladie. Donc, une cataracte chez un enfant, il faut toujours chercher une cause. Et une cataracte unilatérale chez un enfant, elle est d'origine traumatique jusqu'à preuve du contraire.

Généralement, les parents ne trouvent pas de trace de traumatisme et l'enfant le cache s'il est en âge verbal. Mais parfois, c'est des enfants ou des gamins qui sont en âge pré-verbal et on ne peut pas savoir s'il y a une notion de traumatisme ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cataracte unilatérale est d'origine traumatique jusqu'à preuve du contraire.

(25:42 - 26:14)

Ici, c'est une image de cataracte nucléaire. Alors, la première couche, ici, c'est la cournée, la chambre antérieure et ici, à partir d'ici, c'est le cristallat. Alors, la capsule antérieure, c'est la réflexion de cette lumière.

Et le noyau qui est opacifié, c'est pour ça qu'on a dit que la cataracte elle est nucléaire. Alors là, le cocori. C'est quoi le cocori ? C'est une pupille blanche.

Le cocori. Le cocori, chez un adulte, première cause, c'est une cataracte sénile, cataracte de vieillissement. Alors sénile, c'est avec l'âge.

(26:16 - 26:22)

Et là, le cocori. Chez l'enfant, il y a plusieurs étiologies. J'ai cité quelques-uns.

(26:23 - 26:32)

Le plus important, c'est la retinoblastome, la cataracte. C'est les causes. La retinoblastome, c'est la cause la moins fréquente, mais la plus grave, puisque c'est un cancer.

(26:33 - 27:04)

Et la cataracte, c'est la cause la plus fréquente, mais elle est moins grave qu'un cancer. La retinoblastome, c'est une tumeur oculaire maligne de la rétine. C'est le cancer le plus fréquent chez l'enfant, mais le pronostic est beaucoup plus meilleur par rapport à d'autres.

On a parlé tout à l'heure de l'abdominal sarcome, qui est un pronostic plus réservé. La retinoblastome, c'est un cancer qui est de pronostic excellent s'il est bien traité. Alors, l'ectopie cristallinienne.

(27:04 - 27:21)

Le cristallin, on l'a vu dans les cours d'anatomie, il est suspendu par la zonule de zine. Et si vous arrivez à voir, ces striations, c'est la zonule pour différencier la subluxation d'une ectopie. Alors, au cours de l'ectopie, la zonule est saine, sauf qu'elle est étirée.

(27:22 - 27:35)

Et pour la subluxation, elle est rompue généralement à l'origine et elle est traumatique. Un colobum, c'est une anomalie congénitale. C'est une personne qui est née avec une partie qui manque du cristallin.

(27:36 - 28:03)

Ici, c'est le contenu du cristallin qui est sorti dans la chambre antérieure et c'est une cataracte qui est rompue. Alors, pour l'examen du fond 2, soit à l'ophtalmoscope, pour un patient qui ne se déplace pas, même en médecine de vie, médecin généraliste, ou plus spécialisé, c'est à la lampe à fente. Alors, examinez la papille et examinez tout le port postérieur avec la macula.

(28:03 - 28:11)

Examinez le vitré, l'hémorragie. Examinez s'il y a une inflammation. Alors, les hémorragies, on en a plusieurs.

(28:12 - 28:25)

J'ai cité dans le cours plusieurs types. Les exudants, c'est un signe indirect de plusieurs pathologies, mais il est très fréquent au cours du diabète. Alors, il faut savoir que le diabète, c'est vraiment un problème de santé publique chez nous.

(28:26 - 29:13)

Alors, la papille, examinez les bords, l'excavation, la coloration et un signe que je ne cesse de répéter, c'est l'excavation, c'est la partie jaune centrale de la papille et le reste d'ici jusqu'à la périphérie, c'est l'anodore rétinien. Alors, l'excavation, c'est la partie centrale dépourvue de fibres optiques. l'excavation, c'est la partie centrale Donc, il n'y a pas de fibres optiques et bien

sûr, l'anodore rétinien, c'est le passage obligé de toutes les fibres.

(29:13 - 29:49)

L'excavation, tant qu'elle est grande, ça veut dire que les fibres sont en train de dégénérer et ce n'est pas bien et se voit dans le glaucome chronique. Alors ici, je n'arrive pas à voir la vidéo, mais c'est une vidéo qui montrait l'évolution et l'agrandissement progressif de l'excavation au cours de l'évolution d'un glaucome. Alors ici, c'est une petite déchirure.

(29:49 - 29:59)

Ici, c'est une rétine décollée. Il y a un risque de décollement d'une autre déchirure avec une rétine décollée. Alors, j'ai fini la première partie.

(30:00 - 30:33)

Alors, si vous avez des questions, avant que je passe à la session des cours. Des questions? Est-ce que vous avez des questions avant que j'enchaîne? Comment on peut dire que l'excavation est normale ou grande chez une personne qui est âgée? Une excavation normale est inférieure à 5 dixièmes. Primo.

(30:33 - 30:45)

Secondo, une excavation normale est soit ronde, soit à grand axe qui est horizontale. Toute excavation qui est verticale est pathologique. On va revenir sur les images.

(30:47 - 30:56)

Vous voyez ici, c'est une excavation qui est verticale. Comment ça se verticalise? Ici, c'est une excavation de 3 dixièmes. C'est une excavation qui est normale.

(30:56 - 31:25)

Généralement, tout est une excavation normale au-dessous de 5 dixièmes. Soit elle est ronde, soit elle est horizontale, mais verticale, elle est pathologique. J'attends toujours vos questions avant d'enchaîner.

(32:05 - 32:40)

Comment on va reconnaître une hypertonie par la palpation? Par les deux doigts, est-ce que vous voyez la caméra? Vous avez la caméra? Est-ce que vous avez des caméras? Est-ce que vous m'en voyez? D'accord. C'est avec les deux doigts, les deux index, sur le patient. Je vais le faire sur mon œil, mais sur l'œil du patient, donc sur la paupière supérieure.

(32:40 - 33:04)

Et on va appliquer des pressions comme une balance. Une pression sur l'index et sur l'autre,

comme ça. Alors, si vous allez faire cet exercice sur vous, vous allez voir une espèce d'un mouvement ou de pression qui bouge.

(33:07 - 33:21)

On a l'impression que vous appuyez et ça se relâche. Alors, sur un œil qui est très très dur, on a l'impression que vous exercez une pression sur une bille. Et c'est tellement dur.

(33:21 - 33:34)

C'est une bille ou quelque chose de dur. C'est pas cette souplesse qu'on a au niveau de cet œil. C'est vraiment un exercice à faire chez les patients pour apprendre, pour apprécier les différents tonus oculaires.

(33:36 - 33:39)

Mais comment on fait? C'est avec les deux index. On va faire la pression. C'est des mouvements.

(33:40 - 34:29)

La pression sur l'index et sur l'autre, sur l'index et sur l'autre. Mais comment vous allez mesurer? C'est un exercice que vous allez apprendre. Alors, je passe à la session des questions.

Je vois que vous n'avez pas beaucoup de questions. Est-ce que vous avez révisé des gens? Alors, question numéro 1. L'optosis, elle est toujours congénitale. Et par définition unilatérale, la gravité chez l'enfant est jugée par rapport à l'axe visuel, correspond à la rétraction de la paupière supérieure, doit faire rechercher une paralysie oculomotrice associée.

(34:30 - 36:35)

À vos claviers. Alors, des propositions? Oui? Alors, répondez. Alors, je vois, c'est E, c'est E, c'est E. Alors, on corrige.

L'optosis est toujours congénitale? Donc, on a vu qu'il peut se voir chez l'enfant, peut être congénital, comme il peut se voir chez le sujet âgé. Et chez le sujet âgé, il peut être d'origine sénile, un vieillissement des paupières et de la ponévrose. Et il est par définition unilatérale? Non, il peut être unilatéral comme il peut être bilatéral, d'accord? La gravité chez l'enfant est jugée par rapport à l'axe visuel, et je vous ai montré comment on cherche le retentissement par rapport à l'axe visuel et le risque, c'est quoi? C'est l'amblyopie, d'accord? Correspond à la rétraction de la paupière supérieure? Non, au contraire, c'est une chute de la paupière supérieure, d'accord? Il doit faire rechercher une paralysie associée au culot motrice.

Pourquoi? Il est énervé par quel nerf? C'est quel muscle d'abord? Et quelle innervation? Répondez à vos claviers. C'est quel muscle et quel nerf? Et quel muscle? Alors, c'est le releveur de la paupière supérieure et c'est le troie. Et le troie, il a plusieurs branches.

(36:36 - 36:56)

Entre autres, c'est des branches destinées à la culot motricité donc il faut faire rechercher une paralysie au culot motrice associée. Donc c'est bon? pardon, l'image qui illustre que le ptosis peut être chez l'adulte et chez l'enfant. Alors, une autre question.

(36:59 - 37:13)

Alors, les étiologies du ptosis. Il peut être traumatique, le syndrome de Claude Bernard Horner, la paralysie du troie, un ptosis de survenue aiguë chez un adulte, est-ce une urgence? Il peut être sénile. À vos claviers.

(38:01 - 39:52)

Alors, qui peut me définir le syndrome de Claude Bernard Horner? Alors, c'est quoi le syndrome de Claude Bernard Horner? Claude Bernard, c'est une question de sémiologie. Pas de réponse? Alors, on corrige? Alors, le syndrome de Claude Bernard Horner, c'est un signe qui est sémiologique. Qui implique l'ophtalmologie.

Et il est dû à quoi? C'est une tumeur. Vous l'avez vu? Alors, ça commence à devenir plus intéressant. Ariane, c'est quoi? Alors, il se voit quand le syndrome de Claude Bernard Horner? C'est des tumeurs de l'apex pulmonaire.

(39:52 - 40:01)

Donc, vous avez vu ça en pneumologie. Et il associe quoi? Un ptosis, un myosis. Je ne sais pas ce que vous avez écrit.

(40:01 - 40:16)

Oui, d'accord. Alors, ça, c'est plus intéressant. les histologies du ptosis.

Traumatique? Oui, évidemment. On peut avoir une section du releveur ou de son aponeurose. Oui.

(40:17 - 40:24)

Un syndrome de Claude Bernard Horner? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui.

(40:24 - 40:43)

Un syndrome de Claude Bernard Horner? Un grand oui. Une paralysie du trois? Évidemment. Une ptosis aiguë de survenue brutale chez un adulte est une urgence? Alors, à votre avis? Alors, c'est un QCM que j'ai posé juste pour le secouer.

(40:44 - 41:01)

Pour vous secouer un petit peu. Non? Ben, si. C'est un signe qui peut être très grave.

Il peut témoigner d'un anévrisme de la carotide. Donc, il faut envoyer le patient pour une consultation en neuro-ophtalmologie et faire une imagerie cérébrale. En géo-imagerie.

(41:01 - 41:17)

Donc, un ptosis aiguë, il peut témoigner d'une atteinte du 3. D'accord. Le CD3 qui est touché peut s'agir d'un anévrisme de la carotide. Donc, un ptosis aiguë, survenue brutale chez un adulte, c'est une urgence.

(41:17 - 41:36)

Peut-être sénile? Oui. Donc, finalement, quelles sont les réponses justes? Tout est juste. Alors, chez l'enfant, non.

Moi, j'ai parlé d'un ptosis aiguë. Donc, une personne qui est normale, brutalement, elle a fait un ptosis. Alors, s'il est douloureux, c'est une extrême urgence.

(41:38 - 42:13)

Sénile, c'est avec l'âge. C'est le vieillissement. Sénile, c'est le vieillissement.

C'est bon? Sénile, c'est à l'âge. Ça va? Alors, une patiente âgée de 39 ans consulte pour un œil rouge. Alors, écoutez.

(42:14 - 42:30)

Œil rouge, douloureux, avec baisse de la qualité visuelle et photophobie. Alors, d'abord, c'est un tableau qui peut évoquer surtout la présence d'une kératite. Donc, citer et écrire le test qui peut confirmer le diagnostic d'une kératite.

(42:33 - 42:55)

Alors, dites-moi. Alors, décrivez. Fluorescine quoi? Injectable? Alors, décrivez le test.

(43:13 - 43:40)

Une goutte. Installation d'une goutte de fluorescine. Oui.

Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la lumière bleue? Oui. Exactement. C'est ça, en fait, la description entière.

(43:41 - 44:19)

C'est ça, en fait, oui. Alors, l'hémicère dendritique. Quel est votre diagnostic? Oui.

Le diagnostic, c'est un herpès. Donc, il faut donner des antiviraux. Ça répond très, très bien.

(44:19 - 44:36)

C'est le virus qui répond bien aux antiviraux. Par contre, attention, jamais, jamais, jamais de corticoïdes, au moins, sans surveillance médicale. Alors, c'est ça l'aspect d'un lucerde dendritique après l'installation d'une goutte de fluorescine.

(44:40 - 44:57)

Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on dessine en faveur d'une kératite herpétique plutôt d'une kératite à adénovirus? Alors, l'atteinte bilatérale. Qu'est-ce qu'on dessine en faveur d'une kératite herpétique? Donc, on veut éliminer l'adénovirus.

(44:57 - 46:22)

L'atteinte bilatérale, l'aggravation sur corticoïdes, une feuille de fougère, une récurrence possible, et l'évolution épidémique. Allez-y, d'autres réponses. Alors, on corrige ensemble.

(46:22 - 46:38)

Qu'est-ce qu'on dessine en faveur d'une kératite herpétique? Alors, l'atteinte bilatérale, elle est plutôt en faveur d'un adénovirus. C'est une infection avec un nez rouge qui est bilatérale. Un contexte épidémique familial dans une crèche, école, un milieu de travail.

(46:39 - 46:51)

Donc, l'aggravation sur corticoïdes, oui, elle est en faveur d'une kératite herpétique. Par contre, généralement, au début de l'adénovirus, il s'améliore avant d'avoir une aggravation. Oui, c'est juste.

(46:51 - 47:01)

Un ulcère en feuilles de fougère. Parfois, on peut avoir un ulcère, une kératite en feuilles de fougère dans la kératite herpétique. Oui, c'est juste.

(47:02 - 47:22)

Récurrence possible, à votre avis? Oui, la kératite herpétique est récurrence, bien sûr qu'elle est récurrence. Et l'évolution épidémique, par contre, elle est en faveur d'un adénovirus. Alors, une maman ramène son nourrisson pour une pupille blanche.

(47:22 - 48:22)

Qu'est-ce qu'on appelle une pupille blanche? C'est l'étiologie la plus fréquente. Alors, on a déjà dit que la pupille blanche, c'est la coucourie. Et chez l'enfant, l'étiologie la plus fréquente, c'est le cataracte congénital.

(48:22 - 48:48)

Et la plus grave, c'est le retinoblastin. Alors, ici, quelles peuvent être les signes? Les causes d'un nœud rouge sont la baisse de l'acuité visuelle. Donc, un nœud rouge mais sans baisse de l'acuité visuelle.

(48:48 - 50:30)

Une rubéose iréenne, une conjonctivite allergique, une contusion, une sclérite antérieure, une veillite postérieure. Alors, un nœud rouge sans baisse de l'acuité visuelle. Une rubéose iréenne.

(50:33 - 51:02)

Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une rubéose iréenne? Qu'est-ce que ça veut dire une rubéose iréenne? C'est la prolifération du néo-vaisseau au niveau de l'iris. Généralement, ça témoigne d'une ischémie rétinienne profonde. Ça se voit dans le diabète, les occlusions veineuses, et ça témoigne d'un signe de gravité d'une maladie ischémique.

(51:02 - 51:19)

Une maladie ischémique profonde peut donner une baisse de l'acuité visuelle. Donc, c'est faux. Conjonctivite allergique.

C'est juste. Une contusion oculaire. Oui, une petite contusion peut donner un nœud rouge sans baisse de l'acuité visuelle.

(51:19 - 51:29)

Une contusion, pas obligatoirement. Un décollement de rétine hémorragique vitrée peut avoir une petite contusion. Un petit coup de poing ou quelque chose.

(51:31 - 51:40)

Ça donne un nœud rouge sans baisse de l'acuité visuelle. Une sclérite antérieure. Elle est sans baisse de l'acuité visuelle.

(51:40 - 51:45)

C'est une sclérite. C'est la sclère qui est touchée. Une éveillite postérieure, elle donne une baisse de l'acuité visuelle.

(51:55 - 52:08)

Alors, ici, je vous ai donné des propositions et vous allez me relier les réponses en fonction de l'étiologie. Alors, la différence entre un chalazion et le ptosis. Alors, les compléments chalazion et le ptosis.

(52:08 - 52:20)

En fonction de chaque élément, on va discuter cas par cas. On commence par le chalazion. Le chalazion est une tumeur bénigne de la paupière.

(52:22 - 52:31)

Vous allez me dire oui ou non. C'est une position plus basse du bord de la paupière. C'est une vossure ferme de la taille d'un poid sensible.

(52:32 - 53:58)

Peut-être unio-bilatéral, congénital ou acquis, et sans traitement médical ou chirurgical. Alors, pour le chalazion, répondez. Alors, le chalazion, est-ce que c'est une tumeur bénigne de la paupière? C'est une tumeur action bénigne de la paupière? Oui.

(53:59 - 54:07)

Une position plus basse? Non, c'est pas vrai. C'est une vossure ferme? Oui. Peut-être unio-bilatéral? Oui.

(54:08 - 54:17)

Congénital ou acquis? Non. Traitement médical ou chirurgical? C'est juste. Alors, pour le ptosis, les mêmes propositions et répondez.

(55:01 - 57:50)

Alors, pour le ptosis, c'est une position plus basse, peut-être unio-bilatéral, congénital ou acquis, et le traitement, il est chirurgical, pas de traitement médical. Est-ce qu'il y a un traitement médical pour le ptosis? D'accord? Alors, je crois que c'est la dernière ou presque. C'est quoi le chémosis? Alors, est-ce que c'est une sécheresse oculaire? Est-ce que c'est un oedème conjonctival? Est-ce que c'est une tumeur conjonctivale? Alors, le chémosis, c'est un oedème conjonctival.

Dans un contexte traumatique, on peut avoir un chémosis qui est hémorragique, c'est du sang qui s'infiltre sur la conjonctive. Alors que je crois que c'était la dernière diapositive pour la révision. Alors, avant de finir, est-ce que vous avez des questions ou des demandes d'explications? Alors, l'UV-IT et la baisse de la qualité visuelle? Alors, les UV-IT donnent une baisse de la qualité visuelle.

(57:50 - 58:17)

Alors, c'est des cellules inflammatoires et dans la chambre antérieure et dans le vitré, ça donne une baisse de la vue. C'est une inflammation à l'intérieur de l'œil. Ça donne une hyalite, un teint d'âge de chambre antérieure et ça donne une baisse de la vue.

C'est une inflammation à l'intérieur de l'œil, donc automatiquement il y a une baisse de vue.

Alors sur ce, on va terminer cette session et bon courage et à très bientôt. Merci.